

蓄压

蓄压的原料。

蓄压 是一种非法改造的艾奎兰类神经活性药物。其活性核心会极端放大感官显著性与社交推断能力，而来自星脊海怪神经/脊髓液的提取物会破坏人脑对“自我”和“他者”的边界过滤。患者常主诉能听见他人思想，但临床上更接近神经边界破损：外部生理信号、微表情、植入体噪声、环境数据与自身创伤记忆被错误整合为“入侵性他者思维”。少数情况下，患者能捕捉到真实信息碎片，因此该药被黑市包装成共感或读心体验。实际效果高度创伤性，常导致恐慌、高热、心律异常、暴力防御、记忆污染与长期神经损伤。

Baro-Bud 相关神经边界破损

英文可以叫：**Baro-Bud Associated Boundary Failure**

黑市俗称：**渗脑 / 开花 / 同潮**

医生不会说“他能读心”。医生会说：

“患者主诉他能听见别人想法。实际表现更接近感官门控崩溃、情绪归属错误和外部信号强迫性内化。”

再脏一点，Sa 可以翻译成：

“你可以想象...有人在你的脑子上开了个洞，街上所有的泔水都往里灌。”

2. 三层原理：放大、破门、错译

第一层：三甲氧基苯乙胺类活性核心 = 放大器

AQL-358 的基础活性核心负责：

- 感官放大
- 时间感扭曲
- 情绪显著性暴涨
- 睡眠剥夺
- 心率和体温上升
- 威胁识别过敏

- “我懂了 / 我听见了 / 我们连上了”的强烈确信感

这一层像经典致幻/兴奋混合效果，但你不要写成现实药理。写成架空：

它把大脑的“重要性旋钮”拧爆。

平时别人咳嗽一下，大脑会过滤掉。

蓄压状态下，咳嗽变成暗号。

眼神变成判决。

隔壁房间的电流声变成有人在骂你。

别人的沉默变成“他正在想我的死法”。

第二层：星脊海怪神经/脊髓液提取物 = 破门器

这个是你世界观里真正特殊的东西。

星脊海怪不是单体生物逻辑。它们的神经系统里有一种类似深海菌类/集群意识的共生结构。不要写成“它们会心灵感应”，而是写成：

它们靠化学脉冲、低频电场、压力波和神经囊泡，在群体中同步状态。

它们同步的不是完整语言，而是：

- 恐惧
- 方向
- 饥饿
- 疼痛
- 繁殖压力
- 群体移动意图
- 危险来源

也就是说，星脊海怪的“集群意识”本来就on不是诗意的灵魂网络，而是很恶心的生物局域网。

提取物进入人脑后，会干扰：

- 丘脑感官门控
- 胶质细胞调节
- 神经同步阈值

- 情绪归属边界
- 自我/他人区分

用一句硬一点的设定：

星脊提取物不是传递思想，它降低了大脑拒收外部模式的能力。

第三层：人脑把杂讯错译成“思想”

这层最重要。

蓄压患者听见的“别人想法”，不一定是真的思想。它可能来自：

- 微表情
- 呼吸节奏
- 肌肉紧张
- 眼动
- 喉部未发声动作
- 心跳/植入体遥测泄漏
- 电子设备噪声
- 人群情绪感染
- 其他蓄压使用者的异常神经同步
- 星脊材料残留的低频群体信号

但患者的大脑被药物强迫“补全意义”。

所以病人会非常确信：

“不是我猜的。我听见了。”

医生可以更冷地写：

“外部杂讯变成了入侵性他者思维。”

这句话很好用。

3. 为什么偶尔真的像读心？

这点要保留。完全说成幻觉会削弱魅力。最好设成：

蓄压不是稳定读心，但它有时能抓到真实碎片。

因为在 VTG 世界里，人身上有太多信号源：

- 医疗植入体
- 神经接口
- 泵
- 呼吸器
- 义眼
- 义肢
- 工厂传感器
- 环境监控
- 生物材料残留
- 低频通信
- 黑市改造件

蓄压状态下，患者不是“读心”，而是像一台坏掉的收音机，同时扫到十几个频道。
大部分是噪声。
少数是真的。

这会制造恐怖感：

病人说十句疯话。九句是错的。
第十句突然说出护士小时候的名字。

不是因为他成神。
是因为护士的旧义眼、病历腕带、语音残留、表情反应和某个环境数据库碎片，被他破脑子拼成了一个正确答案。

这比纯魔法更吓人。

规则限制：防止它变成超能力

-情绪、方向、意图、碎片

-规则二：越多人越糟

一个人旁边，可能是“模糊侵入”。

十个人旁边，是“脑内菜市场爆炸”。

工厂、夜店、诊所候诊室都会变成地狱。

-高噪声/高植入体密度/星脊材料污染环境：范围变大，但准确性下降。

-共同用药会同步

两个人都用了蓄压，确实可能出现短暂同步。

但这不是浪漫心灵连接。更像两个脑袋同时破洞，中间接了一根污水管。

“听见彼此。”

创伤者更容易被撕开

TBI、PTSD、长期睡眠剥夺、神经植入体、强噪声敏感者，更容易出现严重 ABF。

这能直接压到 Sa。

Ulises 可以说：

“对普通人，这是把门砸坏。对你，这是在一栋已经漏水的楼里开消防栓。”

规则七：星脊原料越粗，越“灵”

纯化越差，越容易出现所谓“心灵相通”。

但这不是效果更好，而是杂质更多、神经侵蚀更强。

黑市会吹：

“原浆蓄压，更真，更近神。”

医生会说：

“未纯化神经囊泡含量过高，脑损伤概率翻倍。”

Sa 会说：

“翻译：这帮傻逼把海怪脊髓汤当圣餐喝。”

Ulises 对 Sa 的解释

这段可以放在诊所，不要长。让它像医生讲给一个聪明但不耐烦的病人听。

Sa:

所以他们真能听见别人想什么？

Ulises:

不。

至少不是你想的那种。

Sa:

不错，这下没那么恶心了。

Ulises:

也并没有。

Sa:

好吧。继续？

Ulises:

正常大脑一直在删东西。声音、脸、呼吸、别人的情绪、自己的恐惧。

你能活着，是因为脑子大部分时间都在说：这个不是我，那个不用管，这个声音没有意义。

Sa:

蕾压把这个功能删掉了？

Ulises:

蕾压把这个功能融化了，露出一个洞。然后往洞里倒海怪神经液。

Sa:

哦操，我好像洞又没懂。

Ulises:

患者不是稳定读心。

他们是失去边界。别人的表情、呼吸、植入体噪声、情绪反应，会被他们的大脑当成自己的念头，或者当成别人塞进来的念头。

偶尔他们会猜中。

猜中的那一次，会让他们相信剩下九十九次也是真的。

Philip:

则该现象不具可靠证据价值。

Ulisés:

对你来说不可靠。

对患者来说，那是正在发生的现实。

Sa:

听起来就是磕嗨了。

蓄压使用者的呓语：

我能听见她没说出口的话。

我能看见人群背后的潮。

我不再孤独。

我们不再隔着皮肤活着。

Sa:

“我们不再隔着皮肤活着。”

什么意思，这人是个剥皮犯？

Philip:

该描述可能指向药物诱发的边界障碍。

Sa:

谢谢，剥皮犯翻译官。

蓄压症状分级

可以用在诊所、道具描述、病例摘要里。

轻度：感官开花

- 颜色过亮
- 声音有边
- 别人的表情“很吵”
- 自己的皮肤像薄了一层
- 觉得能猜到别人下一句话

患者说法：

“他们的脸在说话。”

医生写法：

感官显著性增强，社交线索过度解读。

中度：他者侵入

- 听见“别人想法”
- 觉得房间里所有人都在往自己脑内漏东西
- 情绪不是自己的
- 疼痛共感
- 看到陌生人的记忆碎片感

患者说法：

“他把他妈妈的死塞进我嘴里。”

医生写法：

他者情绪归属错误，伴入侵性意象。

重度：群体溶解

- 自我边界崩溃
- 多人同步恐慌
- 癫痫样发作
- 高热
- 暴力防御
- 认为必须杀死某人才能“安静”
- 长期记忆污染

患者说法：

“这里没有我。这里只有我们。”

医生写法：

急性神经边界破损，群体同步妄想，生命体征不稳定。需隔离降噪、降温、镇静和心律
监控。

Sa 翻译：

“脑子变成公共厕所了。”